NEXO INTELIGÊNCIA CLÍNICA / LEITURAS PARA CONECTAR IDEIAS

Psicologia em Pauta

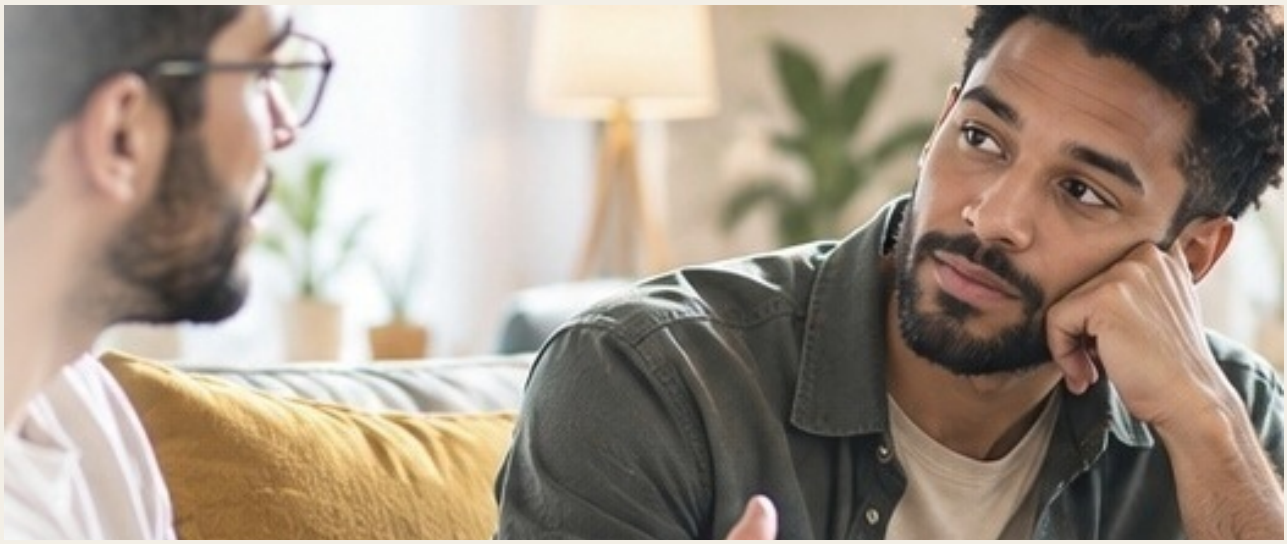
EDIÇÃO 02

NEURODIVERGÊNCIA E COMUNICAÇÃO

Você disse ou só achou que disse?

Neurodivergência, comunicação e o risco de esperar que o outro adivinhe o que você quis dizer.

Texto e curadoria de
Gabriel Alves Batista



Comunicar também envolve contexto e atenção. Acervo editorial próprio · imagem ilustrativa

Edição digital em A4 • Texto selecionável • Referências e links

Uma leitura educativa para ampliar perguntas e possibilidades.

GUIA DA EDIÇÃO

Entre ideias, histórias e perguntas.

Entenda diferenças de interpretação, comunicação clara, sensorialidade e avaliação responsável, com exemplos de casa, escola, trabalho e relações.

Você disse ou só achou que disse? . . . 3
O que é neurodivergência? . . . 4
Característica não é diagnóstico. . . . 5
Como se chega a um diagnóstico responsável? . . . 6
O manual orienta o profissional. . . . 7
Indireta não vem com legenda. . . . 8
A mesma frase muda quando o contexto muda. . . . 9
Quando a intenção e a mensagem se desencontram. . . . 10
Reconhecer o desconforto sem presumir uma causa. . . . 11
O que você realmente disse? . . . 12
Receba a mensagem sem supor que conhece a intenção. . . . 12
Curiosidade pode virar cuidado. . . . 13
Ciência precisa chegar às pessoas. . . . 14
Referências da edição. . . . 15

Continuar a leitura no navegador

A leitura e os exercícios têm finalidade educativa. Exemplos e perguntas ajudam a observar contextos e não substituem avaliação individual.

CAPÍTULO 01

Você disse ou só achou que disse?

A mesma frase pode chegar ao outro com um significado diferente daquele que você imaginou. Isso acontece por cultura, história de vida, idade, contexto, emoção e também por diferenças no modo de perceber pistas sociais e linguagem implícita.

O que está claro dentro da sua cabeça pode continuar invisível para o outro.

Síntese editorial da edição

Por isso, esta edição não ensina "como identificar um neurodivergente". Ela ensina algo mais útil: como compreender diferenças sem transformar cada diferença em diagnóstico, e como falar com mais clareza sem perder gentileza.

> Reconhecer-se em uma situação pode abrir uma pergunta. Não confirma TEA, TDAH ou outra condição.

Se algo desperta sofrimento, prejuízo ou dúvida persistente sobre seu desenvolvimento, vale procurar avaliação profissional.

Pensamento não vem com Wi-Fi. No Behaviorismo Radical, a privacidade se refere a condições de acesso: pensar e sentir não se tornam automaticamente observáveis para outra pessoa. Isso não os coloca fora da natureza ou da análise científica. Relatar o que sentimos também envolve aprendizagem e contexto; o relato precisa ser compreendido, não tratado como uma janela infalível. [13]

CAPÍTULO 02

O que é neurodivergência?

Neurodivergência é um termo amplo, sem fronteiras consensuais, usado para falar de formas de funcionamento e desenvolvimento que diferem do padrão considerado típico. Não é uma categoria diagnóstica única do DSM ou da CID. As abordagens de neurodiversidade têm diferenças entre si e podem considerar tanto barreiras do ambiente quanto dificuldades e necessidades individuais. [6][14]

Não é sobre ser melhor ou pior. É sobre reconhecer diferenças sem transformar diferença em defeito.

Síntese editorial da edição

A comparação do destro e do canhoto ajuda a entender uma parte do problema: ambientes costumam ser planejados para a maioria. Quando a forma de funcionar de alguém é menos comum, pode haver esforço extra, barreiras e necessidade de adaptação.

Dimensão ilustrativa	Diferenças que podem ser percebidas
Percepção	Detalhes e contexto podem receber pesos diferentes.
Atenção	O foco pode oscilar, hiperfocar ou exigir mais esforço.
Sensorial	Sons, luzes, cheiros e texturas podem ser vividos com outra intensidade.
Comunicação	Pistas implícitas e ironias podem não ter o mesmo significado para todos.

> Uma abordagem de neurodiversidade pode coexistir com deficiência, sofrimento e necessidade de suporte. Respeitar identidade não significa negar dificuldades reais. As dimensões do quadro são exemplos heterogêneos, não um perfil compartilhado por todas as pessoas neurodivergentes. [6]

CAPÍTULO 03

Característica não é diagnóstico.

Todo mundo pode se distrair, preferir rotina, se incomodar com barulho, não entender uma ironia ou ficar exausto socialmente. A avaliação clínica pergunta outra coisa: isso forma um padrão? Desde quando? Em quais contextos? Com que impacto? Há explicações alternativas? [1][2][3][4]

Marquei cinco características. Então eu tenho?

Pergunta ilustrativa da edição

Não. Diagnóstico não funciona como bingo. Checklists e vídeos podem levantar perguntas, mas não substituem avaliação profissional.

Pergunta clínica	Descrição educativa da edição
TEA	A descrição clínica do TEA reúne diferenças persistentes de comunicação e interação social e padrões restritos ou repetitivos de comportamento e interesses, que podem incluir respostas sensoriais. Considera desenvolvimento, funcionamento e necessidade de suporte; não se conclui pela presença de um exemplo isolado. [2]
TDAH	Considera-se um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, presença de vários sintomas antes dos 12 anos, manifestação em mais de um contexto e impacto funcional, além de outras explicações possíveis. [4]

Identificação pode abrir uma pergunta. Diagnóstico é o processo que tenta respondê-la com método.

Síntese editorial da edição

CAPÍTULO 04

Como se chega a um diagnóstico responsável?



Uma conversa é parte de uma investigação mais ampla. Acervo editorial próprio · imagem ilustrativa

Não existe uma única conversa, um único teste ou uma única imagem que conte toda a história. Uma avaliação responsável junta informações e verifica se elas formam um padrão coerente.

- Pergunta clínica: o que está acontecendo e o que a pessoa quer compreender?
- História de vida: desenvolvimento, escola, relações, trabalho, saúde e mudanças ao longo do tempo.
- Contextos: como as características aparecem em ambientes e situações diferentes?
- Métodos adequados: entrevistas, anamnese, observação e instrumentos escolhidos para a finalidade.
- Diagnóstico diferencial: o que mais pode explicar essas dificuldades? Sono, saúde, emoções, uso de substâncias, outras condições?
- Devolutiva: o que os dados permitem concluir, quais são os limites e quais próximos passos fazem sentido?

No Brasil, avaliação psicológica é um processo estruturado. Quando houver testes psicológicos, a(o) psicóloga(o) deve verificar a condição de uso no SATEPSI e seguir os manuais técnicos aprovados. Testagem não é sinônimo de avaliação. [9]

CAPÍTULO 05

O manual orienta o profissional.

DSM-5-TR e CID-11 organizam descrições e critérios para aumentar consistência clínica e comunicação entre profissionais. A própria APA ressalta que os critérios do DSM são destinados a profissionais treinados, com julgamento clínico, e não ao uso diagnóstico pelo público geral. [1][5]

“Tenho uma característica” não é igual a “preencho critérios diagnósticos”.

Síntese editorial da edição

Uma mesma manifestação pode ter explicações diferentes. Esquecimento pode aparecer com privação de sono, ansiedade, depressão, uso de substâncias, condições clínicas ou TDAH. Evitar contato visual pode depender de cultura, ansiedade, personalidade, contexto ou TEA. O diagnóstico procura o conjunto e a trajetória, não um comportamento isolado.

Condições do neurodesenvolvimento são avaliadas considerando desenvolvimento e funcionamento ao longo da vida. Em adultos, características podem ter passado despercebidas, sido compensadas ou ficado mais evidentes quando as demandas aumentaram. Isso não significa que a condição "começou" na vida adulta. [2][3][4]

O objetivo não é colecionar rótulos. É entender o que explica melhor o funcionamento da pessoa e quais apoios, adaptações ou tratamentos podem ajudar.

CAPÍTULO 06

Indireta não vem com legenda.

Ser assertivo é dizer o que você precisa com clareza e respeito. Isso não serve apenas para pessoas neurodivergentes: ajuda em diferenças culturais, geracionais, familiares e profissionais.

Como costumamos falar	Uma forma mais clara
Nossa, como a hora passou rápido...	Adorei sua companhia. Agora eu preciso descansar. Vamos marcar de novo?
Faz o que você quiser.	Eu fiquei chateado e quero conversar antes de você ir.
Você foi ótimo hoje!	A sua ajuda organizando a mesa me deixou mais tranquilo. Obrigado.
Quando puder, me manda.	Preciso disso hoje até as 16 h. Se não der, me avise até as 14 h.

Gentileza não é fazer o outro adivinhar com delicadeza. É ajudá-lo a entender.

Síntese editorial da edição

CAPÍTULO 07

A mesma frase muda quando o contexto muda.

Em casa, na escola e no trabalho, a pergunta é a mesma: o outro recebeu o que eu queria comunicar ou recebeu apenas as palavras que eu usei?

Situação	Frase e interpretação possível	Uma orientação mais clara
Em casa / visitas	Nossa, como a hora passou rápido... Pode ser apenas um comentário sobre o horário. Se você quer encerrar a visita, diga isso com carinho.	Adorei que você veio. Agora eu preciso descansar. Vamos marcar de novo?
Na escola	Capricha mais. Quem já sabe o que precisa melhorar pode entender. Quem não sabe fica sem direção.	Revise a ortografia e complete o último exercício. Se tiver dúvida, me chama.
No trabalho	Quando puder, me manda. Sem prazo e sem prioridade, duas pessoas podem organizar o dia de maneiras incompatíveis.	Preciso disso hoje até as 16 h. Se houver impedimento, me avise até as 14 h.

> Exemplos educativos: não descrevem uma reação única de pessoas neurodivergentes.

CAPÍTULO 08

Quando a intenção e a mensagem se desencontram.

Faz o que quiser. E se a outra pessoa fizer?

Situação ilustrativa da edição

Às vezes uma pessoa tenta comunicar frustração por uma indireta; a outra recebe autorização literal. O problema pode estar menos em “quem está certo” e mais na diferença entre intenção e mensagem.

O que alguém quis dizer	O que o outro recebeu
Estou magoado e queria que você ficasse.	Você disse que eu posso ir.

A hipótese do problema da dupla empatia propõe que alguns desencontros entre pessoas autistas e não autistas são recíprocos: pessoas com experiências e formas de comunicação diferentes podem interpretar mal umas às outras. É uma perspectiva de pesquisa, não um critério diagnóstico. [7][8]

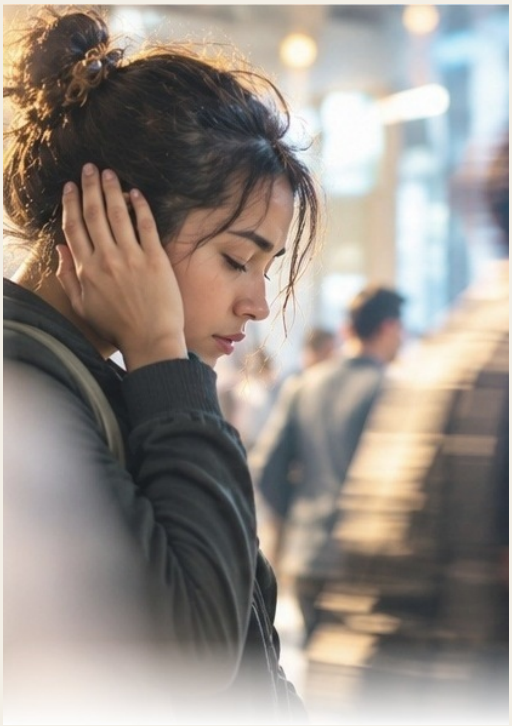
Em um estudo de Cheang e colaboradores, 81 adultos da população geral tiveram mais dificuldade para acompanhar a intensidade das emoções de narradores autistas em algumas condições de uma tarefa com vídeos. Isso apoia a investigação de desencontros de compreensão, mas não descreve toda pessoa autista nem todo encontro; a tarefa não equivale à avaliação de uma relação cotidiana. [8]

Uma relação não fica menos espontânea porque você falou claramente. Às vezes fica apenas menos cansativa.

Síntese editorial da edição

CAPÍTULO 09

Reconhecer o desconforto sem presumir uma causa.



Reconhecer desconforto não é presumir sua causa. Acervo editorial próprio · imagem ilustrativa

O mesmo barulho pode ser só chato para você e muito difícil para outra pessoa.

Diferenças sensoriais podem aparecer no autismo e em outras condições, mas uma reação isolada a som, luz, cheiro ou textura não fecha diagnóstico. [2]

Em vez de	Uma possibilidade de acolhimento
Deixa de frescura, já passou.	Eu vi que esse barulho te incomodou bastante. Quer ir para um lugar mais quieto?

Validar uma experiência não significa afirmar uma causa clínica. Você pode reconhecer o desconforto sem diagnosticar a pessoa.

Acolher não é diagnosticar.

Síntese editorial da edição

CAPÍTULO 10

O que você realmente disse?

Isto é um exercício de comunicação. Não existe placar, resultado ou interpretação clínica.

- “Nossa, essa pia está ficando enorme...” O que foi dito literalmente? Há muita louça na pia. “Lave” ou “me ajude” podem ser intenções, mas não foram verbalizadas.
- Você precisa de silêncio. Qual frase pede isso com menos adivinhação? “Preciso de dez minutos em silêncio, por favor.”
- “Você foi incrível hoje!” Como tornar o elogio mais claro? Diga o comportamento: “Sua ajuda na reunião organizou minhas ideias.”
- “Você nunca me chama.” Como transformar crítica em pedido? “Eu gosto de estar com você e queria que você também me convidasse às vezes.”

O que estava claro dentro de você, mas nunca saiu em palavras?

Síntese editorial da edição

CAPÍTULO 11

Receba a mensagem sem supor que conhece a intenção.

O objetivo não é decorar “como uma pessoa neurodivergente pensa”. É lembrar que ninguém tem acesso automático à experiência e ao ponto de vista do outro. Perguntar, escutar e conferir o entendimento oferece mais informação do que presumir intenções.

Troque de lugar e observe as informações que a mensagem realmente oferece.

- Visita: “Nossa, como a hora passou rápido...” Você entenderia como despedida ou apenas como comentário sobre o horário?
- Escola: “Capricha mais.” Se você fosse aluno, saberia exatamente o que precisa mudar?
- Trabalho: “Quando puder.” Existe prazo, prioridade ou consequência visível?

> - Relacionamento: “Faz o que quiser.” É autorização, frustração ou pedido de proximidade? Se é importante, por que não dizer?

Distinções para continuar a leitura:

- Característica não equivale a diagnóstico.
- Identificação não equivale a avaliação.
- Objetividade não equivale a grosseria.
- Diferença não equivale a defeito.
- Acolher não equivale a afirmar uma causa clínica.

CAPÍTULO 12

Curiosidade pode virar cuidado.

Se você se reconheceu em vários exemplos e isso traz sofrimento, prejuízo, conflitos frequentes ou dúvida persistente, vale procurar um profissional. Identificação não confirma diagnóstico, mas pode ser um bom motivo para conversar com alguém habilitado.

Quem pode participar da avaliação e do cuidado?

- Psicólogo(a) / neuropsicólogo(a): pode investigar aspectos emocionais, comportamentais, do desenvolvimento e, quando indicado, funções cognitivas e neuropsicológicas. [9][10]
- Psiquiatra, neurologista, pediatra ou outras especialidades médicas: podem avaliar aspectos clínicos conforme idade, hipótese e necessidade.
- Fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras áreas: podem integrar o cuidado quando comunicação, sensorialidade, autonomia e participação cotidiana pedem avaliação específica.

A Atenção Primária à Saúde é a principal porta de entrada do SUS. Para investigação de TEA, o Ministério da Saúde orienta procurar a UBS mais próxima. A equipe acolhe e pode encaminhar a serviços especializados, como CAPSi, CER ou serviços de referência, conforme necessidade e organização da rede local. A oferta varia entre municípios. [11][12]

Um caminho possível, conforme a rede local:

- UBS: acolhe e coordena.
- Avaliação: define necessidades.
- Rede: encaminha quando indicado.

CAPÍTULO 13

Ciência precisa chegar às pessoas.

Esta edição foi construída para fazer uma ponte: manter o rigor de uma discussão clínica sem exigir que o leitor fale a língua da universidade. Simplificar não é empobrecer. É organizar o conhecimento para que ele possa ser compreendido, questionado e usado com responsabilidade.

Compreender não é diagnosticar.

Síntese editorial da edição

Neurodiversidade pode ajudar a olhar para diferenças com menos estigma. O diagnóstico, quando necessário, ajuda a organizar hipóteses, reconhecer necessidades de suporte e planejar cuidado. Uma coisa não precisa apagar a outra.

Regra de ouro desta edição: se você quer que o outro entenda algo importante, fale com clareza. E, se algo sobre seu funcionamento merece investigação, procure um profissional habilitado.

> Material educativo. Não substitui avaliação profissional.

FONTES PARA APROFUNDAR

Referências da edição.

[1] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR. 5. ed., text rev. Washington, DC: APA Publishing, 2022. Ver também as atualizações oficiais de critérios e texto publicadas pela APA em 2025.

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/about-dsm

[2] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. What Is Autism Spectrum Disorder? Psychiatry.org, revisão médica jan. 2024.

https://www.psychiatry.org/patients-families/autism/what-is-autism-spectrum-disorder

[3] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Autism Spectrum Disorder. DSM-5-TR Fact Sheets. Washington, DC: APA, 2022.

https://www.psychiatry.org/getmedia/d48f7fa6-b6c8-4f6c-888b-b0adfeb9f5b6/APA-DSM5TR-AutismSpectrumDisorder.pdf

[4] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. What is ADHD? Psychiatry.org. Revisão médica out.2025. Acesso em 17 out.2026.

https://www.psychiatry.org/patients-families/adhd/what-is-adhd

[5] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. Geneva: WHO, 2024.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240077263

[6] DWYER, Patrick. The Neurodiversity Approach(es): What Are They and What Do They Mean for Researchers? Human Development, v. 66, n. 2, p. 73-92, 2022. DOI: 10.1159/000523723.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9261839/

[7] MILTON, Damian E. M. On the ontological status of autism: the “double empathy problem”. Disability & Society, v. 27, n. 6, p. 883-887, 2012. DOI: 10.1080/09687599.2012.710008.

https://kar.kent.ac.uk/62639/1/Double%20empathy%20problem.pdf

[8] CHEANG, Rachael T. S. et al. Do you feel me? Autism, empathic accuracy and the double empathy problem. Autism, v. 29, n. 9, p. 2315-2327, 2025. DOI: 10.1177/13623613241252320.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613241252320

[9] CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP nº 31/2022. Estabelece diretrizes para avaliação psicológica e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI. Brasília, DF: CFP, 2022.

https://satepsi.cfp.org.br/faq.cfm

[10] CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Manual Neuropsicologia: Ciência e Profissão. Brasília, DF: CFP, 2023. Cap.2: Avaliação neuropsicológica.

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Neuropsicologia_manual-4.pdf

[11] BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Primária. Brasília, DF. Acesso em 17 out.2026.

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/

[12] BRASIL. Ministério da Saúde. Onde posso procurar diagnóstico para TEA no SUS? Saúde de A a Z - Autismo. Atualizado em 8 out. 2025. O primeiro passo indicado é procurar a UBS; encaminhamentos dependem da necessidade e da rede local.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/faq/onde-posso-procurar-diagnostico-para

[13] SKINNER, B. F. Science and Human Behavior. New York: Macmillan, 1953. Cap.XVII: Private events in a natural science, p. 257-282. Edição digital: B.F.Skinner Foundation.

https://www.bfskinner.org/wp-content/uploads/2014/02/ScienceHumanBehavior.pdf

[14] NHS ENGLAND. Report of the independent ADHD Taskforce: Part 2. Anexo 1: Glossary. 2025. Acesso em 17 out. 2026.

https://www.england.nhs.uk/long-read/report-of-the-independent-adhd-taskforce-part-2/

Continue a conexão.

Abrir esta edição no site da NEXO

Texto e curadoria de Gabriel Alves Batista